Insights consolidados – Sprint 3

Proyecto: Infecciones respiratorias agudas en Argentina: cambios entre 2019 (prepandemia) y 2025 (pospandemia). Equipo 6: Maria Silvana Sosa, Pablo Nuñez, Estela Gomez y Pablo Velázquez. Fecha: 1 de noviembre de 2026.

Se seleccionaron 4 insights: uno por cada pregunta de análisis (¿qué cambió?, ¿cuándo?, ¿dónde?) y uno de contexto sobre la bronquiolitis. El análisis es descriptivo: se comparan dos años completos (2019 y 2025, semanas epidemiológicas 1 a 52) sin atribuir causas, hacer predicciones ni proponer soluciones. Cada insight se apoya en una página del tablero Power BI (proyecto_Salud_base_v4.pbix, carpeta Analysis del repositorio). El contexto externo (Boletín Epidemiológico Nacional) se indica como coincidencia y no forma parte del tablero.

INS-001 · El aumento de las notificaciones se concentra en la ETI y en escolares y adultos; en los menores de 2 años bajan la neumonía y la bronquiolitis.

SECCIÓN	CAMPO DE REGISTRO	VALOR
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**ID del Insight:**	INS-001
	Título Descriptivo:	El aumento de las notificaciones se concentra en la ETI y en escolares y adultos; en los menores de 2 años bajan la neumonía y la bronquiolitis.
	Categoría:	Distribución por evento y grupo de edad (página Eventos).
Contexto y Evidencia Estadística	**Patrón Identificado:**	Entre 2019 y 2025 las notificaciones aumentaron un 24,2% (1.266.350 → 1.572.497), pero no de forma pareja: • ETI +45,5%, neumonía +5,6% y bronquiolitis −36,7%. • La ETI pasa del 68% al 79% del total y crece en todos los grupos de edad: 45 a 64 años +73%, 5 a 14 años +65%, 65 años o más +61%. • En menores de 2 años la neumonía baja un 47% y la bronquiolitis un 39%. • Los menores de 2 años pasan del 31,3% al 18,7% de las notificaciones.
	Variable(s) Crítica(s):	evento_grupo, edad_agrupada, cantidad_casos, año. Medidas: Variacion %, Var ETI, Var Neumonia, Var Bronquiolitis.

	Grado de Confianza:	Alto: años completos, mismas semanas y agrupación de eventos validada contra los totales del EDA. Las notificaciones sin edad especificada quedan fuera de la comparación por edad.
El Insight (Conocimiento Profundo)	**Interpretación:**	En 2025 la composición de las notificaciones es distinta a la de 2019: tienen más peso la ETI en escolares y adultos, y menos peso los menores de 2 años.
	Impacto Potencial / Valor:	Valor: el total anual oculta comportamientos opuestos (eventos que suben y eventos que bajan). Para describir el período pospandemia hay que mirar cada evento y grupo de edad por separado.
Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)	**Acción Propuesta:**	No aplica: el análisis es descriptivo. Se comunica en la página Eventos (tarjetas y matriz evento × edad) y en las filminas 6 (técnica) y 3 (divulgación).
	Prioridad:	Alta (responde la pregunta principal).
	Sprint Futuro	Línea futura: incorporar los años 2020-2024 para ver en qué momento cambió la composición.

INS-002 · La temporada 2025 duró lo mismo que la de 2019, pero se adelantó 2 semanas y tuvo un pico 42% más alto.

SECCIÓN	CAMPO DE REGISTRO	VALOR
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**ID del Insight:**	INS-002
	Título Descriptivo:	La temporada 2025 duró lo mismo que la de 2019, pero se adelantó 2 semanas y tuvo un pico 42% más alto.
	Categoría:	Tendencia temporal / estacionalidad (página Temporada).

Contexto y Evidencia Estadística	**Patrón Identificado:**	Temporada = semanas con al menos la mitad de las notificaciones de la semana pico de cada año. • 2019: SE 19 a 40; pico en la SE 26 con 45.850 notificaciones. • 2025: SE 17 a 38; pico en la SE 24 con 65.184 notificaciones (+42,2%). • Ambas duran 22 semanas; inicio, pico y fin ocurren 2 semanas antes en 2025. • La curva de 2025 se separa de la de 2019 desde la SE 11-12 (SE 12: 28.506 vs. 20.481).
	Variable(s) Crítica(s):	semanas_epidemiologicas, año, cantidad_casos. Medidas: Semana pico, Pico casos, Variación pico %.
	Grado de Confianza:	Alto para el corrimiento de inicio y fin. Medio para la semana exacta del pico de 2019 (SE 24 y SE 26 con valores casi iguales).
El Insight (Conocimiento Profundo)	**Interpretación:**	La estacionalidad pospandemia conserva su forma y duración, pero ocurre antes en el calendario y concentra más notificaciones en las semanas centrales. Contexto: coincide con lo informado por el Boletín Epidemiológico Nacional N° 763 (SE 26/2025, pág. 58): aumento de influenza A (H1N1) desde la SE 11 "con un adelanto del ascenso estacional respecto de lo registrado en años anteriores".
	Impacto Potencial / Valor:	Valor: el adelanto no se ve en el total anual; solo aparece al comparar semana por semana.
Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)	**Acción Propuesta:**	No aplica: el análisis es descriptivo. Se comunica en la página Temporada y en las filminas 7 (técnica) y 4 (divulgación).
	Prioridad:	Alta.
	Sprint Futuro	Línea futura: verificar si el adelanto se repite con 2026 completo (el BEN N° 831 informa inicio desde la SE 10) y cruzar con la vigilancia de laboratorio.

INS-003 · Las provincias con mayor incidencia son las mismas antes y después de la pandemia: Catamarca, La Rioja, Jujuy y Chaco.

SECCIÓN	CAMPO DE REGISTRO	VALOR
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**ID del Insight:**	INS-003
	Título Descriptivo:	Las provincias con mayor incidencia son las mismas antes y después de la pandemia: Catamarca, La Rioja, Jujuy y Chaco.
	Categoría:	Distribución territorial – incidencia cada 100.000 habitantes (página Provincias).
Contexto y Evidencia Estadística	**Patrón Identificado:**	La incidencia nacional pasó de 2.759 a 3.426 notificaciones cada 100.000 habitantes. • Catamarca, La Rioja, Jujuy y Chaco ocupan los cuatro primeros puestos en ambos años; Catamarca registra 13.509 en 2025, 3,9 veces el promedio nacional. • Mayores ascensos: Tucumán (17.º → 6.º), Córdoba (20.º → 10.º), Chubut (21.º → 13.º). Mayores descensos: San Juan (10.º → 21.º), Corrientes (9.º → 17.º), Santa Cruz (11.º → 19.º). • Buenos Aires, la provincia con más notificaciones en números absolutos, queda 15.ª por habitante.
	Variable(s) Crítica(s):	DimProvincia[jurisdicción], cantidad_casos, poblacion_total (INDEC 2022), año. Medidas: Incidencia 100k, Incidencia 2019, Incidencia 2025.
	Grado de Confianza:	Medio: Santa Fe y CABA presentan subnotificación (−90% y −66%) y no son comparables; se usa la población del Censo 2022 para ambos años.
El Insight (Conocimiento Profundo)	**Interpretación:**	Al ajustar por población, la distribución territorial no sigue el tamaño de las provincias: las de mayor incidencia mantienen su posición, mientras que en el resto del ranking hay reordenamientos importantes.

	Impacto Potencial / Valor:	Valor: comparar por habitante en lugar de por cantidad cambia la lectura e identifica las provincias con mayor incidencia relativa en ambos períodos.
Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)	**Acción Propuesta:**	No aplica: el análisis es descriptivo. Se comunica en la página Provincias (mapas 2019 y 2025 con la misma escala) y en las filminas 8 (técnica) y 5 (divulgación).
	Prioridad:	Media.
	Sprint Futuro	Línea futura: validar con la fuente los datos de Santa Fe y CABA y usar proyecciones de población por año.

INS-004 · La bronquiolitis baja más cuanto menor es la edad del bebé: −49% en menores de 6 meses.

SECCIÓN	CAMPO DE REGISTRO	VALOR
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**ID del Insight:**	INS-004
	Título Descriptivo:	La bronquiolitis baja más cuanto menor es la edad del bebé: −49% en menores de 6 meses.
	Categoría:	Contexto de INS-001: bronquiolitis por grupo de edad y cobertura de vacunación (página Vacuna VSR).
Contexto y Evidencia Estadística	**Patrón Identificado:**	Bronquiolitis notificada, 2019 vs. 2025: • Menores de 6 meses: 85.968 → 43.690 (−49,2%). • 6 a 11 meses: 89.852 → 54.990 (−38,8%). • 12 a 23 meses: 77.130 → 54.636 (−29,2%). • Cobertura nacional de la vacuna VSR en gestantes 2024: 67,8% (de 47,1% en Misiones a 93,3% en Tierra del Fuego).
	Variable(s) Crítica(s):	grupo_edad_desc, año, cantidad_casos (evento = Bronquiolitis); cobertura_pct (vacuna = Virus Sincicial Respiratorio). Medidas: Var bronquiolitis <6m, Cobertura VSR %, Cobertura VSR nacional.

	Grado de Confianza:	Medio: la baja por edad es clara, pero la relación por provincia entre cobertura y baja es débil (r = −0,34 sin Santa Fe ni CABA) y la cobertura disponible es la de 2024.
El Insight (Conocimiento Profundo)	**Interpretación:**	La baja es mayor en el grupo que protege la vacuna VSR aplicada en el embarazo (incorporada al Calendario Nacional en 2024). Coincide con el BEN N° 831 (SE 41/2026, pág. 12): "los años 2024, 2025 y 2026 presentan un marcado descenso" de bronquiolitis. Los datos muestran la coincidencia, no la causa.
	Impacto Potencial / Valor:	Valor: identifica en qué grupo de edad se concentra la baja y deja una línea de base para seguir la bronquiolitis por edad en los próximos años.
Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)	**Acción Propuesta:**	No aplica: el análisis es descriptivo. Se comunica en la página Vacuna VSR y en las filminas 6 (técnica y divulgación).
	Prioridad:	Media.
	Sprint Futuro	Línea futura: incorporar la cobertura de la campaña 2025 y los datos de 2026 completos.